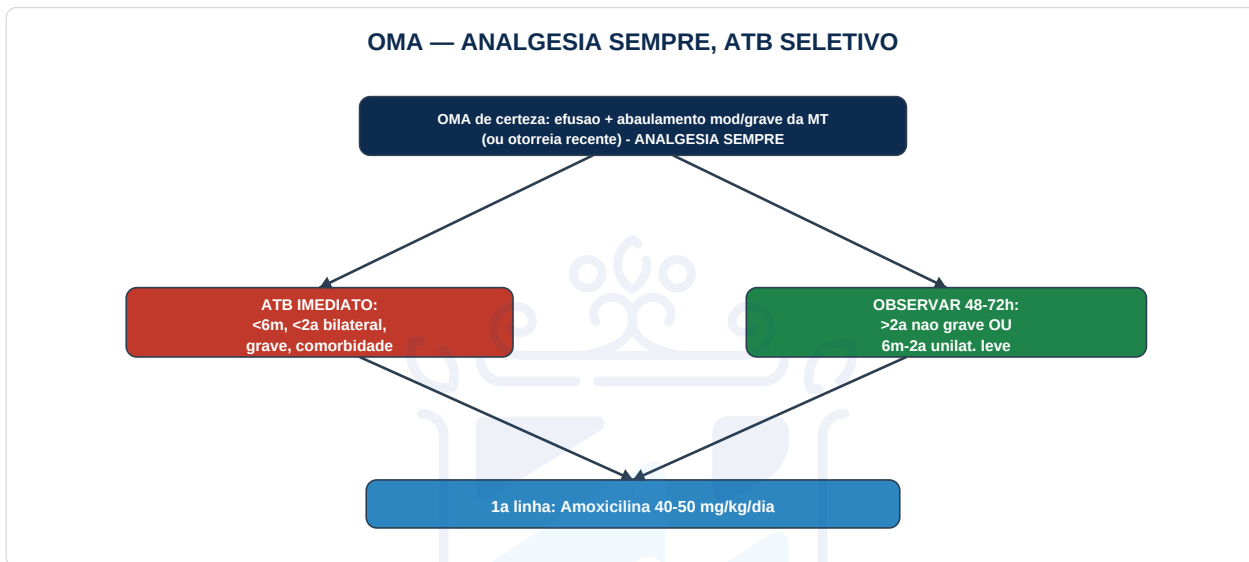


OTITE MÉDIA AGUDA — ATB x OBSERVAÇÃO

FLUXOGRAMA — ATB IMEDIATO x OBSERVAÇÃO



DIAGNÓSTICO DE CERTEZA

CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS

- Início agudo (< 48h) + EFUSÃO na orelha média + sinais/sintomas inflamatórios
- Efusão evidenciada por UM: abaulamento moderado/grave da MT (sinal mais específico)
- OU otorreia recente (não atribuível a otite externa)
- OU abaulamento leve + otalgia recente (<48h) OU abaulamento leve + hiperemia importante
- ATENÇÃO: hiperemia ISOLADA da MT (ex.: criança chorando) NÃO é critério suficiente
- Patógenos: S. pneumoniae, H. influenzae (não tipável), M. catarrhalis

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO

Risco	Perfil
Baixo	Criança > 2 anos, unilateral, sem sinais de gravidade
Intermediário	6 meses-2 anos, unilateral, sem gravidade
Alto	< 6 meses, bilateral, sinais de gravidade, comorbidades

1) CONTROLE DA DOR (TODOS OS CASOS)

Rx ANALGESIA OBRIGATÓRIA

Paracetamol 15 mg/kg/dose VO 6/6h
OU Ibuprofeno 10 mg/kg/dose VO 6/6h
OU Dipirona 15 mg/kg/dose VO 6/6h
CONTRAINDICADO: gotas otológicas analgésicas se suspeita/confirmação de perfuração da MT (ototoxicidade)
A analgesia é o pilar mesmo nos casos em observação sem antibiótico

2) ANTIBIÓTICO IMEDIATO x OBSERVAÇÃO

ATB imediato se	Observar 48-72h se
Toda criança < 6 meses	6 meses-2 anos: OMA unilateral não grave, dx incerto
6m-2a com OMA bilateral de certeza	> 2 anos: OMA não grave (uni ou bilateral)
Qualquer idade com OMA grave (otalgia severa, febre $\geq$ 39, otorreia)	Condição: família confiável + reavaliação garantida em 48-72h
Comorbidades (imunodef., anomalias craniofaciais)	Iniciar ATB se piora ou sem melhora em 48-72h

3) ANTIBIOTICOTERAPIA

Rx ESQUEMAS E DURAÇÃO

1a linha: Amoxicilina 40-50 mg/kg/dia (até 80-90 mg/kg/dia em alta resistência) VO
Falha em 48-72h, uso de amoxicilina nos últimos 30 dias, ou conjuntivite purulenta (*H. influenzae*):
Amoxicilina + Clavulanato
Alergia não anafilática: cefalosporina; anafilática: macrolídeo/clindamicina
Duração: < 2 anos ou quadro grave = 10 dias | > 2 anos leve/moderado = 7 dias

RED FLAGS — OMA COMPLICADA

AVALIAR IMAGEM / ORL / INTERNAÇÃO

- Edema/hiperemia/flutuação RETROAURICULAR e dor à mastoide -> MASTOIDITE
- Paralisia facial
- Rigidez de nuca, sinais meníngeos, rebaixamento -> complicação intracraniana
- TC de ossos temporais se: suspeita de mastoidite, paralisia facial, sinais intracranianos
- Timpanocentese (especializada): falha de múltiplos esquemas, complicação supurativa, imunossupressão grave

CHECKLIST DE ALTA E ENCAMINHAMENTO

ANTES DE LIBERAR

- ☐ Dor controlada/tolerável (< 4/10); afebril ou febre controlada; criança ativa, sem toxemia
- ☐ Otoscopia documentada; sem sinais de complicação (mastoidite, paralisia facial)
- ☐ Receita e dosagens explicadas; orientação de reavaliação em 48-72h se observação
- ☐ Retorno IMEDIATO: piora da dor, febre alta persistente, otorreia, edema/vermelhidão retroauricular, rigidez de nuca
- ☐ ORL se: OMA recorrente ($\geq$ 3 episódios/6 meses ou $\geq$ 4/ano) ou efusão persistente $\geq$ 3 meses

MODELO DE TRANSFERÊNCIA (OMA complicada)

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Criança ____ anos, ____ kg, OMA ____ (uni/bilateral) há ____; otalgia ____/10; febre ____; otorreia: sim/não.
- Complicação suspeita: mastoidite / paralisia facial / meningite. Retroauricular: edema/flutuação.
- Conduta: analgesia, ATB _____. Solicito avaliação ORL/neurocirurgia / UTI pediátrica / TC.
- Manter analgesia e acesso venoso pérvio no transporte; acompanhante obrigatório.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Lactente de 10 meses com OMA bilateral de certeza, febre 38,5, sem comorbidades. Qual a conduta?

- A) Observação por 48-72h sem antibiótico
- B) Antibioticoterapia imediata (amoxicilina) + analgesia
- C) Apenas gotas otológicas analgésicas
- D) Corticoide oral
- E) Antiviral

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o sinal otoscópico mais específico de OMA?

- A) Hiperemia isolada da membrana timpânica
- B) Abaulamento moderado a severo da membrana timpânica
- C) Cerume abundante
- D) Membrana timpânica translúcida
- E) Reflexo luminoso presente

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Em qual situação é aceitável a observação vigilante (48-72h) sem antibiótico na OMA?

- A) Criança < 6 meses
- B) Criança > 2 anos com OMA não grave e família confiável com reavaliação garantida
- C) OMA grave com otorreia
- D) Imunossuprimido
- E) OMA bilateral em lactente de 1 ano

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual achado sugere mastoidite, complicação da OMA?

- A) Hiperemia da orofaringe
- B) Edema/hiperemia retroauricular com dor à palpação da mastoide
- C) Coriza
- D) Tosse seca
- E) Conjuntivite

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual é o antibiótico de primeira linha na OMA não complicada?

- A) Azitromicina
- B) Amoxicilina
- C) Ciprofloxacino
- D) Ceftriaxona endovenosa
- E) Clindamicina

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Crianças 6 meses-2 anos com OMA BILATERAL de certeza têm indicação de antibiótico imediato (amoxicilina), sempre com analgesia. A observação reserva-se a quadros unilaterais não graves > 2 anos (ou 6m-2a unilateral leve).

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O abaulamento moderado a severo da membrana timpânica é o sinal otoscópico mais específico de OMA. A hiperemia isolada (especialmente em criança chorando) NÃO é critério suficiente.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A observação vigilante (48-72h) é aceitável em crianças > 2 anos com OMA não grave (ou 6m-2a unilateral não grave com dx incerto), DESDE QUE a família seja confiável e haja reavaliação garantida.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Edema, hiperemia e flutuação retroauricular com dor à palpação da mastoide sugerem mastoidite — complicação da OMA que requer avaliação de imagem (TC), ORL e frequentemente internação.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A amoxicilina é o antibiótico de primeira linha na OMA. Amoxicilina-clavulanato fica para falha em 48-72h, uso recente de amoxicilina ou conjuntivite purulenta associada (*H. influenzae*).

SM24
Suporte ao Plantão Médico